Instituto de Análisis y Gestión

Gobernanza de la inversión en salu

Lima, 11 de septiembre de 2025 | 8:00 - 9:30 pm

Instituto de Análisis y Gestión - IAGES

Consultora especializada en sistemas de salud con un enfoque en equidad

- Diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas e intervenciones.
- Desarrollo de capacidades de los actores para mejorar los sistemas y organizaciones de salud.

Midori de Habich

mdehabich@iages.com.pe

Paulina Giusti

pgiusti@iages.com.pe

Flor Philipps

fphilipps@iages.com.pe

Profesionales Asociados a IAGES

Profesionales de alto nivel, reconocidos en el ámbito de la salud, pública y privada, con amplia experiencia en sistemas de salud, a nivel político, estratégico y operativo.

IAGES es un espacio donde colaboramos, trabajando en equipos temáticos, con una vocación por la excelencia técnica y la visión de un sistema de salud cada vez más integrado y centrado en las personas, efectivo y eficiente.

Profesionales Asociados a IAGES

Giovann Alarcón Rubén Cano Jaime Chang

Ricardo Chuquimia Víctor Cuba Piero del Carmen

Seimer Escobedo Carlos Gazzo Pedro Grillo Willy Hakim

César López Cecilia Ma Rocío Mosqueira

Edgardo Nepo Augusto Portocarrero Hernán Ramos

Luis Seminario Augustín Silva Oscar Ugarte

Walter Vigo José Villegas

Abarcamos temas clave en la agenda sanitaria

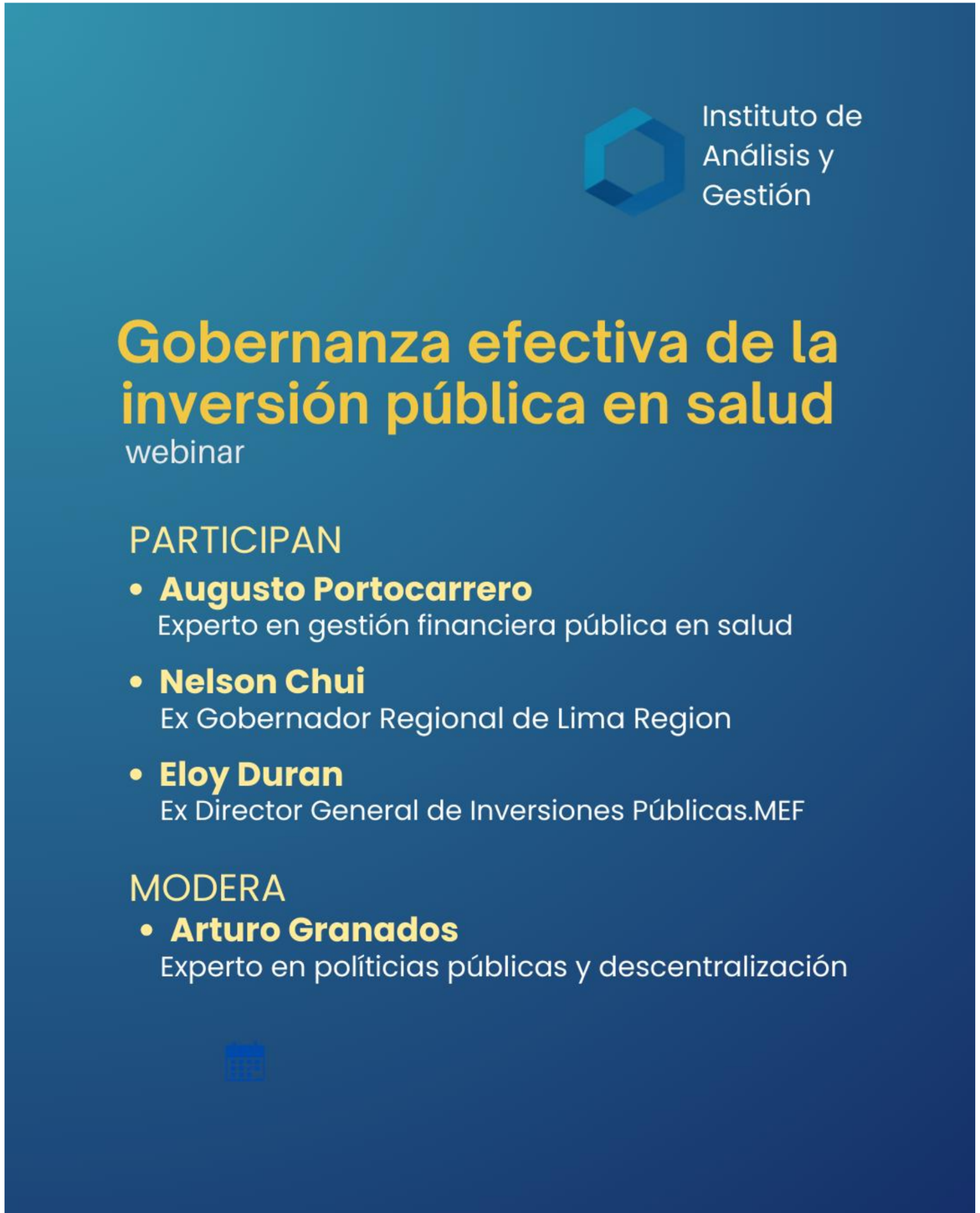
- Enfermedades transmisibles y no transmisibles
- Seguridad sanitaria y Una Sola Salud
- Cobertura universal de salud
- Redes integradas de salud
- Gobernanza en salud
- Financiamiento de salud
- Articulación intersectorial público-privado-sociedad civil
- Mejora continua de la gestión de organizaciones públicas y privadas.
- Gestión del conocimiento
- Estudios e investigaciones

Motivación de este webinar

Han pasado más de diez años desde la promulgación del DL 1157 (2013)

Queremos reunir a los actores para **reflexionar** sobre la gobernanza de la inversión pública en salud.

Abrir **oportunidades** para la fortalecer la **integración** del sector público, sector privado y la sociedad civil en el sistema de salud.



Programa

¿Por qué hablar de la gobernanza de la inversión en salud?

Caso Perú: Gobernanza de inversiones. Lecciones aprendidas de 2011-2016

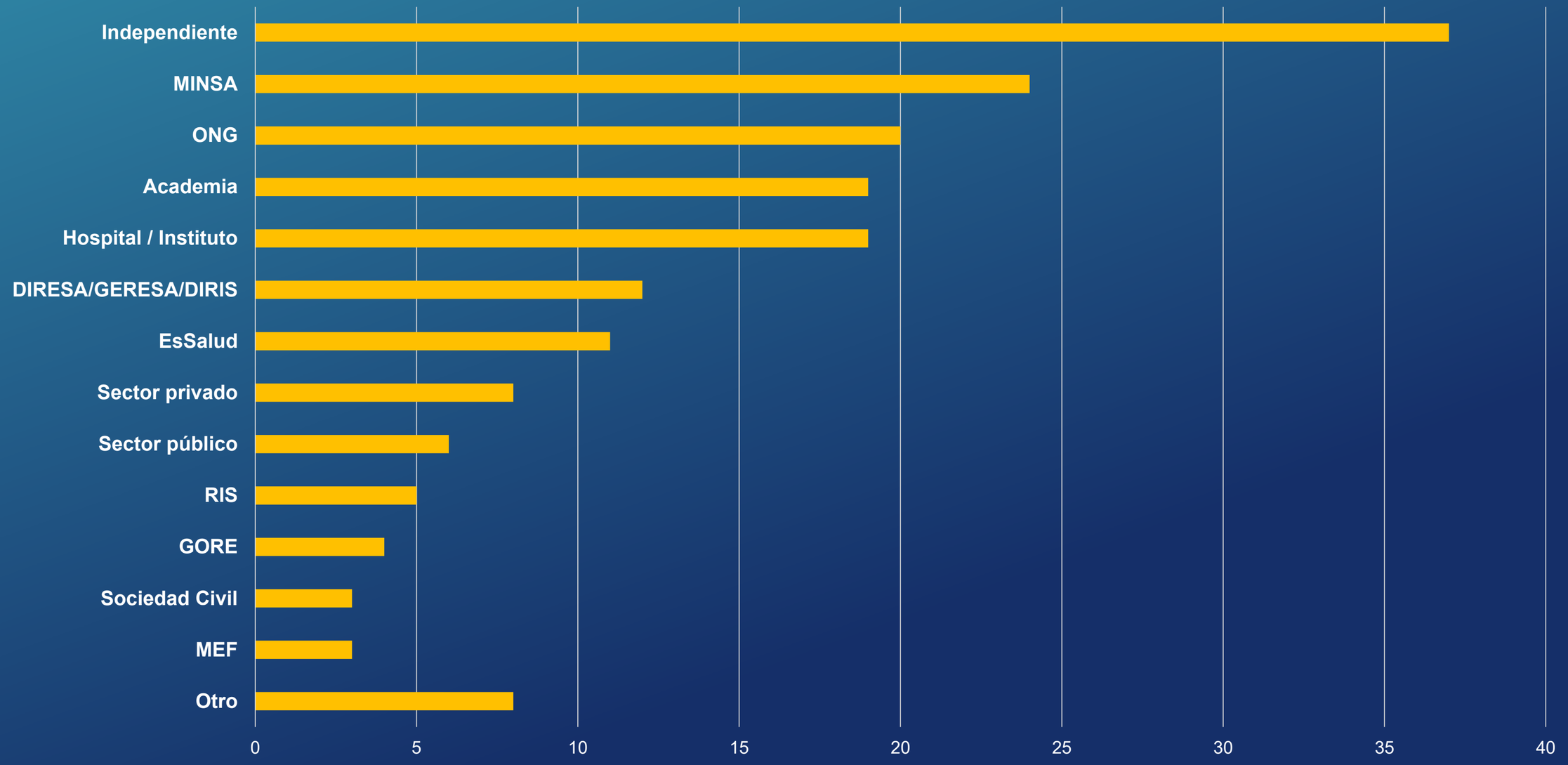
Panel – Augusto Portocarrero, Nelson Chui y Eloy Durand.

Preguntas de los asistentes

Modera: Arturo Granados

Conclusiones – Midori de Habich

¿Quiénes nos acompañan? Total registrados 210



¿Por qué debemos hablar de la gobernanza de la inversión en salud?

El sistema necesita un **proceso ordenado y predecible** de toma de decisiones, para incrementar la racionalidad y capacidad de su oferta.

Implica el planeamiento de las inversiones del sistema, desde una **perspectiva sectorial y territorial**; la formulación, ejecución, puesta en operación y mantenimiento.

Gobernar el proceso para asegurar el cumplimiento de la política de expansión y sostenimiento de la oferta de cuidados de la salud.

Instituto de Análisis y Gestión

Gobernanza efectiva de la inversión pública en salud

Augusto Portocarrero

Agenda

- Situación encontrada en 2012. Avances y retos
- Política de inversiones en salud – 2013 (DL. 1157)
- Financiamiento de la política
- Espacios de participación y negociación
- Resultados
- Lo aprendido

Avances encontrados en 2012

- Proyecto PARSALUD (BID-BM): fortalecimiento de infraestructura de los establecimientos materno-perinatales.
- Comisión Intergubernamental de Salud (**CIGS**): espacio participación del MINSA y los Gobiernos Regionales (DIRESA).
- Comités Regionales de Inversión (CRI) y los Comités Locales de Inversión (CLI) del MEF
- Listado de **establecimientos estratégicos** discutidos y acordado con los gobiernos regionales. (RM 632-2012/MINSA el 20/07/2012).

Retos enfrentados en 2012

- Necesidad de una **política clara de inversiones** en el sector: La “política” provenía de la presión de alcaldes y gobernadores.

- Pasar a **planificación territorial** de la inversión: La inversión se pensaba por establecimiento.

- Fortalecer la **capacidad del MINSA de brindar asistencia técnica** a lo largo del ciclo de inversión.

- **Ineficiencia** en la inversión: En 2008 había 3,296 proyectos sin financiamiento. Desfase entre gasto de capital y gasto corriente.

Política de inversiones en salud – 2013 (DL. 1157)

Objetivo: mecanismos e instrumentos de coordinación para planeamiento, priorización y seguimiento de la **expansión y sostenimiento de la oferta de los servicios de salud**, en todos los prestadores públicos del sector salud en el marco de la rectoría del MINSA en la política nacional de salud.

- La política orienta planes de **largo plazo ***
- Los planes tienen un **enfoque territorial, multianual** y basado en servicios (Unidades Prestadoras de Servicios).
- MINSA realiza el **seguimiento y evaluación** de los planes de expansión y sostenimiento de la oferta pública de servicios de salud, desde la fase de **planeamiento hasta la puesta en operación.**

* Plan Sectorial Intergubernamental y el Plan Regional Multianual de Inversiones en Salud considerando el Marco Macroeconómico Multianual

Financiamiento de la política de inversiones

En coordinación con el MEF el **monto anual era asignado al MINSA**. Se incluía, el gasto corriente para el inicio de las operaciones de los establecimientos.

Transferencias para los establecimientos priorizados después de la firma de **convenios entre el MINSA y el GORE**.

Asistencia técnica del MINSA a los GORE para la elaboración de expedientes y los cronogramas

Siguiendo el cronograma de la inversión, en su momento, se transfería los montos para **la puesta en marcha del establecimiento** con el compromiso del GORE de la asignación para el siguiente año.

Espacios articulados de participación y negociación

Reunión bianual

MINSA y ANGR

CIGS

Comisión Intergubernamental de Salud

MINSA y DIRESAs

CRIIS

Comités Regionales Intergubernamen-tales de Inversión en Salud

GORE y GL

AT de **MINSA y MEF**

CMIS compuesto por el MINSA, GORE EsSalud, el MINDEF y el MININTER, y otros prestadores públicos. **No llegó a funcionar**

El CRIIS

Conformado por el GORE y sus roles eran:

a. **Priorizar y seleccionar** de forma concertada la lista de ideas de proyectos de inversión

b. Revisar y aprobar los informes de **seguimiento** al Plan Regional Multianual de Inversiones en Salud (PRMIS).

c. Proponer medidas para fortalecer la **gestión y ejecución** de la inversión en salud en su respectivo ámbito de competencia.

d. Aprobar el **orden de prelación** de la lista de ideas de proyectos de inversión, expuestas en el PRMIS.

Miembros del CRIIS

a. **Gobernador(a)** Regional, quien lo presidirá.
b. **Alcaldes** distritales y provinciales.
c. Gerente(a) Regional del Área de Planeamiento y Presupuesto.
d. Director(a) de la Dirección o Gerencia Regional de Salud, el(la) cual cumple las funciones de Secretario(a) Técnico.

- El Ministerio de Salud designará su representante para participar en el CRIIS como facilitador.

Resultados

Consenso por niveles

Duplicidad entre niveles

Por servicios

Por categoría

Competencias

Por territorio

Por establecimiento de salud

2 – 3 años promedio

6 – 7 años promedio de ejecución

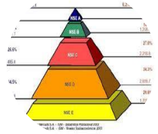
Tomado de: Midori de Habich . Política Nacional de Inversión en Salud y Gobiernos Locales. Octubre 2012

Resultados

Inversión en establecimientos estratégicos

Inversión en hospitales

Foco



Salud pública + Plan de beneficios (PEAS)

Salud pública

Alcance

1,774.8millones - 2015

857.1 millones - 2011

Presupuesto

Tomado de: Midori de Habich . Política Nacional de Inversión en Salud y Gobiernos Locales. Octubre 2012

Resultados

Tabla 5: Estado de avance en la inversión en infraestructura en salud a Junio 2016

Estado	HOSPITAL NACIONAL	HOSPITAL REGIONAL	HOSPITAL PROVINCIAL (ESTRATÉGICO)	CS ESTRATEGICO	CS/PS NO ESTRATÉGICO	TOTAL
CULMINADO	2	6	21	95	44	**168**
POR CULMINAR	0	4	7	9	15	**35**
EN MARCHA	9	24	120	85	27	**265**
TOTAL	**11**	**34**	**148**	**189**	**86**	**468**

Fuente: Oficina de Gestión de Inversiones-OGPPM MINSA

Tomado de: MINSA. Informe para la Transferencia de Gestión del Ministerio de Salud. Período 2011-2016.

Resultados

Cambio de comportamiento de los actores

- Cambios en la relación MINSA – MEF: Financiamiento multianual
- Cambios en la relación Gobiernos Locales – MINSA: Ya no tenían que venir a Lima para abogar por sus proyectos.
- Cambios en la relación GORE – Gobiernos Locales: Consensos en las regiones para el crecimiento de la oferta de salud.

Lo aprendido

Sostenibilidad política

- Mantener activos los espacios de negociación para legitimar objetivos y arreglos normativos
- Obtener respaldo de la presidencia y acuerdos precisos con el MEF

Sostenibilidad económica

- Incorporar al MEF desde el principio es clave para conseguir el financiamiento. Los acuerdos multianuales requieren de algún nivel de formalización.
- Garantizar el uso de los recursos asignados

Lo aprendido

Sostenibilidad técnica

- Incorporación del MEF desde el inicio para institucionalizar los arreglos normativos
- Fortalecer equipos administrativos de las ejecutoras a cargo de las inversiones.
- Fortalecer áreas del MINSA (administración y planificación) para dar asistencia técnica a los gobiernos regionales.

Instituto de Análisis y Gestión

Panel

Nelson Chui
Eloy Duran
Augusto Portocarrero
Modera: Arturo Granados

Instituto de Análisis y Gestión

Conclusiones

Midori de Habich

Instituto de Análisis y Gestión

Antes de despedirnos:

Breve encuesta

https://forms.office.com/r/jPw2HWN4HG

Gracias

Para preguntas relacionadas a este webinar
contacto: nordinola@iages.com.pe